Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
1ª Vara Cível da Comarca de Santa Cruz do Sul

Rua Ernesto Alves, 945 - Bairro: Centro - CEP: 96810144 - Fone: (51) 3098-5791 - Balcão Virtual: (51) 995120095 - Email: frsantcruz1vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5012984-51.2024.8.21.0026/RS

AUTOR: MARILIA GARCIA MARTIN

RÉU: UNIMED - COOPERATIVA DE SERVICOS DE SAUDE DOS VALES DO TAQUARI E RIO PARDO LTDA.

SENTENÇA

MARÍLIA GARCIA MARTIN ajuizou a presente ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência em face da **UNIMED - Cooperativa de Serviços de Saúde dos Vales do Taquari e Rio Pardo Ltda.** Aduziu a parte autora, em síntese, ser portadora de asma grave, apresentando diagnóstico clínico de bronquiectasia agravado por infecção de bactérias pseudomonas. Disse que por conta dos problemas de saúde, se encontra submetida a oxigenação mecânica. Frisou que os medicamentos de uso contínuo já utilizados não possuem o condão de tratar a infecção bacteriana que lhe acomete, devido a sua gravidade e resistência medicamentosa, sendo que já fez e faz uso de inúmeros medicamentos para tratar a sua condição asmática que, nos últimos tempos, não tem apresentado grande avanço devido a bactéria alojada em seu pulmão. Referiu que, por tal razão, o seu médico pneumologista prescreveu, por prazo indeterminado, o medicamento Colistimetato de Sódio, na busca de tratar a infecção bacteriana aguda, considerando que os demais medicamentos antes prescritos não foram capazes de estancar a crise infecciosa. Relatou que diante da recomendação médica urgente, o médico pneumologista preencheu a prescrição do medicamento diretamente na guia da ré, contudo, após o referido pedido junto à demandada, foi surpreendida por negativa de fornecimento. Sustentou que a negativa de fornecimento se dera por razões injustificadas. Asseverou ser inconteste que além do medicamento Colistimetato Sódico possuir recomendação técnico-científica, a droga tem registro na Anvisa, recomendação da CONITEC e incorporação ao SUS, sendo infundada qualquer alegação da ré em relação à eficácia, validade e recomendação do medicamento. Dissertou sobre as normais legais que entende aplicáveis ao caso em tela. Ao final postulou, a título de tutela de urgência e também de forma definitiva, que a ré forneça, imediatamente, tratamento de saúde com o medicamento Colistimetato de Sódio, nos termos da prescrição médica apresentada, bem como de outros que se mostrem necessários no decorrer do tratamento da doença objeto da ação; ou, no caso de impossibilidade de seu fornecimento, que a Unimed seja responsabilizada financeiramente pelo fornecimento dos recursos necessários para o custeio do tratamento, até a plena recuperação da sua saúde. Pediu o deferimento da gratuidade da justiça. Acostou documentos (evento 1).

Recebida a inicial, foi concedida a gratuidade de justiça à autora e deferida tutela de urgência (evento 9).

A parte ré informou o cumprimento da tutela de urgência (evento 20).

Citada, a ré apresentou contestação. Afirmou que a requerente é beneficiária de contrato de plano de assistência à saúde coletivo empresarial, ambulatorial – hospitalar – obstétrico nacional, cujo contrato fora firmado em 01/09/2011, pela Mitra Diocesana de Santa Cruz do Sul. Disse que o contrato fora firmado na vigência da Lei nº. 9.656/98 (Lei de Planos de Saúde – LPS), sendo, portanto, designado plano "regulamentado", sujeitando-se ao regime e regulamentação da referida lei, bem como às normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), nos termos do art. 1º, § 1º e art. 35, caput, ambos da LPS. Esclareceu que, muito embora vigente a alteração legislativa oriunda da Lei nº 14. 454, de 21 de setembro de 2022, sobretudo em relação aos seus efeitos, posto que há parágrafo claro ao estabelecer os requisitos para coberturas que vão além das previsões do Rol da ANS, não se está a amparar a negativa meramente por ausência de previsão do rol, mas, antes disso, por haver dispositivo legal que prevê, de forma expressa, a não obrigação de cobertura assistencial para medicamentos de uso domiciliar que não forem antineoplásicos. Mencionou que conforme estabelecido pela Resolução Normativa nº 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), especificamente em seu Artigo 17, §1º, inciso VI, a exclusão assistencial para o fornecimento de medicamentos utilizados em tratamento domiciliar é permitida. Asseverou que no caso em questão, o medicamento colistimetato de sódio, cujo fornecimento foi solicitado, enquadra-se na definição de medicamento para tratamento domiciliar e, nesse sentido, não há obrigatoriedade de cobertura assistencial para o fornecimento deste fármaco, conforme as disposições legais supracitadas. Dissertou sobre as normas legais aplicáveis à espécie. Requereu a improcedência da ação. Juntou documentos (evento 24).

A demandada interpôs agravo de instrumento em face da decisão que deferiu a tutela de urgência (evento 27).

Houve réplica (evento 36).

Instado, o MP declinou de intervir no feito (evento 41).

Foi provido o agravo de instrumento interposto pela demandada, revogando a tutela de urgência outrora deferida (evento 44).

Determinou-se às partes que manifestassem o interesse na produção de outras provas (evento 45).

A parte autora não apresentou manifestação quanto ao interesse na produção de provas (evento 51), tendo a ré postulado o julgamento antecipado da lide (evento 57).

Vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório.

Decido.

Passo ao julgamento antecipado da lide, uma vez que a matéria sobre a qual versa o litígio é de fato e de direito, aquela devidamente demonstrada por prova documental, na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Outrossim, inexistindo preliminares a enfrentar e tendo a demanda observado regular tramitação, passo ao julgamento do mérito desta demanda.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que incidem à espécie as disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a situação dos autos se enquadra no disposto pelo seu art. 3º, §2º, devendo, portanto, as cláusulas contratuais respeitarem as regras dispostas na legislação consumerista.

Gize-se, ainda, que a situação deve ser interpretada à luz dos preceitos contidos no CDC, a fim de garantir o direito da parte hipossuficiente na relação, inclusive como já restou sufragado pelo STJ, através da Súmula 608. Assim, o contrato deve ser sempre interpretado da maneira mais favorável ao consumidor. Nesse sentido:

> *AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS DO ART. 300 PREENCHIDOS. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PLANO REGULAMENTADO. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. COBERTURA MÍNIMA OBRIGATÓRIA. ART. 12, DA LEI 9.656/98.* ***OS CONTRATOS DE PLANOS DE SAÚDE ESTÃO SUBMETIDOS AO CÓDIGO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, POIS ENVOLVEM TÍPICA RELAÇÃO DE CONSUMO****. A NÃO APRESENTAÇÃO DO CONTRATO NÃO É ÓBICE, NO PRESENTE CASO, À CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, PORQUANTO, DEVIDAMENTE PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, RESTOU COMPROVADO O VÍNCULO CONTRATUAL E A PREVISÃO DE COBERTURA PARA AS TERAPIAS POSTULADAS, ASSIM COMO A URGÊNCIA NA REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO. NÃO SE SUSTENTA A TESE DA OPERADORA DO PLANO NA TENTATIVA DE SE EXIMIR DE CUMPRIR A OBRIGAÇÃO, EIS QUE, SE TRATANDO DE PLANO DE ABRANGÊNCIA NACIONAL E CONSIDERANDO A ATUAÇÃO DA UNIMED PORTO ALEGRE EM SISTEMA DE INTERCÂMBIO, A RÉ É RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 50474333120258217000, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mauro Caum Gonçalves, Julgado em: 23-04-2025)*
>
> *APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TERAPIA MULTIDISCIPLINAR. REEMBOLSO. RESCISÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS, QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. Trata-se de ação indenizatória na qual objetiva a parte autora o reembolso dos valores dispendidos, a declaração de inexistência de débito pelas sessões de terapia na clínica NOAH, com a retomada do plano de saúde e o custeio das terapias com o tratamento de saúde multidisciplinar nas clínicas indicadas pelo médico assistente, ou no mínimo uma clínica especializada em ABA, bem como indenização a título de danos morais, julgada parcialmente procedente na origem.****O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de seguro, na medida em que se trata de relação de consumo, consoante traduz o artigo 3º, §2º do CDC e inteligência da Súmula 608 do STJ****. No caso telado, conforme laudo médico apresentado com a inicial (evento 1, LAUDO8), a parte autora é portadora do Transtorno do Espectro Autista - TEA - CID F84.0. (...) DUPLA APELAÇÃO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA E APELAÇÃO DA PARTE RÉ DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 50675526320228210001, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 21-03-2024)*

No que concerne ao caso sob exame, analisando a prova documental apresentada pelos litigantes, constato que a autora é beneficiária de plano de saúde firmado com a requerida, conforme evento 24-CONTR2.

No que concerne à prescrição do medicamento postulado nesta demanda, o laudo médico anexado ao evento 6-LAUDO2, firmado pelo médico Eduardo Dreher Hermes, CRM nº 29232, demonstra que a requerente possui diagnóstico de Bronquiectasias e necessita utilizar o medicamento Colistimetato de Sódio 1.000.000 UI.

Conforme defendido pela ré em sede de contestação, a negativa de fornecimento do remédio prescrito fora amparada no fato de haver expressa exclusão do fornecimento de medicamento para tratamento domiciliar, conforme disposto no art. 10, inc. VI, da Lei nº 9.656/1998.

Acerca da matéria, preceituam os seguintes dispositivos legais, *in verbis*:

> *- **Lei nº 9.656/1998**:*
>
> *"Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:* ***(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)***
>
> *[...]*
>
> *VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do art. 12;"*
>
> *"Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:* ***(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)***
>
> *I - quando incluir atendimento ambulatorial:*
>
> *[...]*
>
> *c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes;*

[...]

II - quando incluir internação hospitalar:

g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar; ***(Incluído pela Lei nº 12.880, de 2013)***

*- **Resolução Normativa n° 465/2021 ANS:***

"Art. 17. A cobertura assistencial de que trata o plano-referência compreende todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os atendimentos de urgência e emergência previstos nesta Resolução Normativa e seus Anexos, na forma estabelecida no art. 10 da Lei nº 9.656, de 1998.

Parágrafo único. São permitidas as seguintes exclusões assistenciais:

[...]

VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, com exceção dos medicamentos previstos nos incisos IX e X do art. 18, e ressalvado o disposto no art. 13;"

"Art. 18. O Plano Ambulatorial compreende os atendimentos realizados em consultório ou em ambulatório, definidos e listados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, e os atendimentos caracterizados como de urgência e emergência, conforme definições constantes na Lei n.º 9.656 de 1998 e regulamentação infralegal específica vigente, não incluindo internação hospitalar ou procedimentos para fins de diagnóstico ou terapia que, embora prescindam de internação, demandem o apoio de estrutura hospitalar por período superior a doze horas, ou serviços como unidade de terapia intensiva e unidades similares, e devendo garantir cobertura para:[...]

IX - quimioterapia oncológica ambulatorial, entendida como aquela baseada na administração de medicamentos para tratamento do câncer, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes (medicamentos empregados de forma associada aos medicamentos para o tratamento do câncer com a finalidade de intensificar seu desempenho ou de atuar de forma sinérgica ao tratamento) que, independentemente da via de administração e da classe terapêutica, necessitem, conforme prescrição do médico assistente, ser administrados sob intervenção ou supervisão direta de profissionais de saúde dentro de estabelecimento de saúde;

X - medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar, assim como medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso, respeitando o disposto nos Anexos desta Resolução Normativa e, preferencialmente, as seguintes características:

a) medicamento genérico: medicamento similar a um produto de referência ou inovador, que se pretende ser com este intercambiável, geralmente produzido após expiração ou renúncia da proteção patentária ou de outros direitos de exclusividade, comprovada a sua eficácia, segurança e qualidade, e designado pela Denominação Comum Brasileira - DCB ou, na sua ausência, pela Denominação Comum Internacional - DCI, conforme definido pela Lei n.º 9.787/1999; e

b) medicamento fracionado: medicamento fornecido em quantidade distinta da embalagem original, conforme necessidade do paciente e definição do órgão competente, esta atualmente a cargo da ANVISA."

Infere-se dos dispositivos legais acima transcritos que, efetivamente, os planos de saúde não estão obrigados a fornecerem medicamentos de uso domiciliar, excetuados aqueles relativos ao tratamento de neoplasias, cujo fornecimento é obrigatório em virtude de expressa previsão legal, e aqueles previstos no Rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

No caso em exame, afiro que o medicamento postulado pela parte autora (Colistimetato de Sódio) não possui cobertura para tratamento domiciliar relacionado às patologias que acometem a demandante. Com efeito, não se trata de medicamento a ser ministrado em nível de internação hospitalar, além de não se enquadrar nas exceções do ao art. 10 da Lei dos Planos de Saúde.

Diante deste cenário, resta indubitável que a situação retratada nesta demanda diz respeito a medicamento de uso domiciliar, que pode ser manejado/utilizado/injetado em ambiente domiciliar, bem como que não se trata de medicamento antineoplásico, circunstâncias estas que afastam o dever de a requerida custear o tratamento no caso em testilha.

Nesse sentido, inclusive, a decisão do agravo de instrumento n° 5252434-47.2024.8.21.7000/RS, ao revogar a tutela de urgência deferida no feito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. USO DOMICILIAR. TUTELA DE URGÊNCIA. O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da ANS constitui apenas a referência básica para os planos privados, conforme redação expressa do § 12 do art. 10 da Lei n. 9.656/98. No entanto, este mesmo artigo de lei, em seu inciso VI, autoriza que as operadoras dos planos de saúde excluam cobertura para medicamento para tratamento domiciliar, ressalvados os tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral e medicamentos de uso em home care. ***Medicamento prescrito (colistimetato de sódio - Polimixina E) que é de uso domiciliar, sendo administrado por nebulização, e não está incluído na categoria dos antineoplásicos, não se inserindo, portanto, nas hipóteses em que a operadora do plano está obrigada à cobertura dos custos.*** *Decisão proferida na origem reformada. Ausência dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência (CPC, art. 300). AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 52524344720248217000, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em: 27-11-2024)*

No mesmo sentido é também a jurisprudência do TJ/RS, em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. ***PLANO DE SAÚDE.*** *CUSTEIO DE INSUMO PARA CONTROLE GLICÊMICO. ROL TAXATIVO DA ANS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO EM FACE DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER VISANDO CUSTEIO INTEGRAL PELA OPERADORA DE SAÚDE DO APARELHO FREESTYLE LIBRE E DEMAIS INSUMOS NECESSÁRIOS AO SEU USO EM RAZÃO DE DIAGNÓSTICO DE DIABETES MELLITUS TIPO 1. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE EM VERIFICAR SE EXISTE A OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA DO APARELHO FREESTYLE LIBRE E INSUMOS NECESSÁRIOS AO TRATAMENTO DA DIABETES MELLITUS TIPO I. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.* ***CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ, É LÍCITA A EXCLUSÃO***

DE MEDICAMENTOS DE USO DOMICILIAR PELA OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE, SALVO NAS EXCEÇÕES PREVISTAS EM LEI, COMO TRATAMENTOS ANTINEOPLÁSICOS E HOME CARE. 4. O ROL DA ANS É TAXATIVO, E O EQUIPAMENTO EM QUESTÃO NÃO SE ENQUADRA NAS EXCEÇÕES QUE PERMITEM A COBERTURA OBRIGATÓRIA DE INSUMOS FORA DA LISTA. LAUDOS TÉCNICOS E NOTAS TÉCNICAS ANALISADAS INDICAM QUE O EQUIPAMENTO NÃO APRESENTA VANTAGENS INEQUÍVOCAS SOBRE OS MÉTODOS CONVENCIONAIS DE AFERIÇÃO DE GLICEMIA. 5. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O MÉTODO TRADICIONAL DE AFERIÇÃO DE GLICOSE REPRESENTE RISCO À SAÚDE DO PACIENTE OU SEJA INEFICAZ. IV. DISPOSITIVO5. APELO NÃO PROVIDO. (Apelação Cível, Nº 50137587920228210017, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 26-06-2025)

*DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. **PLANO DE SAÚDE.** PEDIDO DE COBERTURA DO ANTICORPO MONOCLONAL (ANTI-CGRP) GALCANEZUMABE. **FÁRMACO DE USO DOMICILIAR**. NÃO DEMONSTRADA A PROBABILIDADE DO DIREITO. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. AGRAVO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da ação em que a parte objetiva seja a operadora do plano de saúde compelida a custear o tratamento com anticorpo monoclonal (anti-CGRP) Galcanezumabe devido à gravidade do quadro clínico de migrânea, vulgarmente conhecida com enxaqueca, com aura (CID 10 G43) crônica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em dirimir a obrigatoriedade das operadoras dos planos de saúde a custear medicamentos de uso domiciliar em sede de tutela de urgência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Para a concessão da tutela provisória de urgência é necessário que estejam presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito da parte e, ainda, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 4. **É lícito que se excetue o fornecimento de tratamento domiciliar, independentemente de se tratar de medicamento ou insumo, quando não previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, à exceção dos antineoplásicos**. 5. É possível a contratação acessória de cobertura de medicamentos domiciliares, de caráter facultativo. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Tutela de urgência revogada. Agravo de Instrumento provido. Tese de Julgamento: "Tratando-se de medicamento de uso domiciliar e ausente demonstração de contratação acessória que obrigue a operadora do plano de saúde à cobertura de medicamento domiciliar, descabe a imposição de cobertura em sede de antecipação de tutela de urgência." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998, art. 10, inc. VI; RN n.º 310/2012 da ANS. Jurisprudência relevante citada: n/a.(Agravo de Instrumento, Nº 50525942220258217000, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 26-06-2025)*

*PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. SEGUROS. **PLANO DE SAÚDE.** BENEFICIÁRIO PORTADOR DE TEA. PRELIMINARES DE SENTENÇA ULTRA PETITA E PERDA DO OBJETO REJEITADAS. TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. DEVER DE OBSERVÂNCIA DA REDE PRIVADA. MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. **USO DOMICILIAR. AUSENTE DEVER DE COBERTURA**. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) 8. **É lícito que se excetue o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar - administração em ambiente externo ao de unidade de saúde (não abrangido o home care) -, salvo os antineoplásicos, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes, bem como os serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente (Arts. 10, incs. V e VI e 12, da Lei nº 9.656/98).** 9. Caso dos autos em que o medicamento postulado - à base de canabidiol -, indicado para o tratamento de Epilepsia e do Transtorno do Espectro Autista, embora possua registro na ANVISA e seja comercializado nas farmácias nacionais, é de uso domiciliar. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação parcialmente provida. Dispositivos relevantes citados: ANS, Resolução Normativa nº 566/2022, art. 4º. Lei nº 9.656/1998, art. 10, inc. VI. Jurisprudência relevante citada: REsp 1692938/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 04/05/2021.(Apelação Cível, Nº 50187189320238210033, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 26-06-2025)*

*APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. **NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO** SEM REGISTRO NA ANVISA. **ADMINISTRAÇÃO DOMICILIAR**. TEMA 990 DO STJ. APLICAÇÃO. APELO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME APELAÇÃO CÍVEL CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE PEDIDO DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO LECANEMAB (LEQEMBI), PRESCRITO PARA TRATAMENTO DE ALZHEIMER EM FASE INICIAL, AO FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE REGISTRO SANITÁRIO JUNTO À ANVISA E ADMINISTRAÇÃO EM REGIME DOMICILIAR. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE EM SABER SE HÁ OBRIGAÇÃO DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EM FORNECER MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA E DESTINADO À ADMINISTRAÇÃO DOMICILIAR. III. RAZÕES DE DECIDIR O **ART. 10, V E VI, DA LEI Nº 9.656/1998, EXCLUI DA COBERTURA OBRIGATÓRIA MEDICAMENTOS** IMPORTADOS NÃO NACIONALIZADOS E **DE USO DOMICILIAR, SALVO EXCEÇÕES LEGAIS.** O STJ, NO TEMA 990, FIRMOU TESE NO SENTIDO DE QUE AS OPERADORAS DE PLANO DE SAÚDE NÃO ESTÃO OBRIGADAS A FORNECER MEDICAMENTOS SEM REGISTRO NA ANVISA. A EVENTUAL APROVAÇÃO DO MEDICAMENTO POR AGÊNCIA INTERNACIONAL E O PEDIDO DE REGISTRO EM TRÂMITE NÃO AFASTAM A LEGALIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA, CONSIDERANDO-SE A DISTINÇÃO ENTRE O DEVER ESTATAL E A OBRIGAÇÃO CONTRATUAL DA OPERADORA PRIVADA. AUSENTE PRÁTICA ABUSIVA CONTRATUAL OU VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. IV. DISPOSITIVO E TESE APELO NÃO PROVIDO. TESE DE JULGAMENTO: "1. AS OPERADORAS DE PLANO DE SAÚDE NÃO ESTÃO OBRIGADAS A FORNECER MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA. 2. **É LEGÍTIMA A NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR QUANDO AUSENTE EXCEÇÃO LEGAL EXPRESSA**."(Apelação Cível, Nº 50203999720238210001, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 26-06-2025)*

Logo, correta a negativa de cobertura no caso em concreto.

Destarte, a improcedência das pretensões deduzidas nesta demanda é medida impositiva.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação de obrigação de fazer que MARÍLIA GARCIA MARTIN move em face da UNIMED - Cooperativa de Serviços de Saúde dos Vales do Taquari e Rio Pardo Ltda.

Sucumbente, arcará a autora com o pagamento/reembolso da Taxa Única de Serviços Judiciais e das despesas processuais, bem como de honorários advocatícios ao patrono da parte ré, os quais fixo, considerando a natureza desta demanda, o julgamento antecipado da lide, o grau de zelo e o trabalho desempenhado pelo profissional, bem como o tempo de duração do processo, em 10% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC. O valor dos honorários deverá ser corrigido pelo IPCA desde esta data, bem como ser acrescido de juros moratórios pela Taxa Selic, deduzido o IPCA, incidentes a partir do trânsito em julgado desta sentença.

Resta, contudo, suspensa a exigibilidade dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 98, §3°, do CPC, uma vez que a autora é beneficiária da gratuidade de justiça.

Sentença publicada e registrada pelo sistema.

Partes intimadas eletronicamente.

Com o trânsito em julgado, dê-se baixa.

Documento assinado eletronicamente por **JOAO FRANCISCO GOULART BORGES, Juiz de Direito**, em 01/08/2025, às 16:30:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10087838459v2** e o código CRC **f3c311ea**.